Prévention, diagnostic et traitement des infections sur matériel endo-urétéral de l'adulte

Recommandations de bonne pratique
Comité d'infectiologie de l'AFU
Juin 2020

Diapositives validées par le comité des référentiels de la SPILF le 12 mai 2021

Sociétés partenaires



















Définition

- Matériel endo-urétéral
  - Sonde JJ
  - Sonde urétérale
  - Sonde de néphrostomie

Prévention

- En présence de matériel endo-urétéral, il est recommandé:
  - ✓ de ne pas rechercher ni traiter une colonisation
  - ✓ sauf en cas de grossesse ou avant une chirurgie de l'appareil génito-urinaire

- En cas de pose ou de changement de matériel endo-urétéral, il est recommandé
  - ✓ de faire un ECBU dans les 10 jours précédents et de réaliser un antibiogramme pour chaque bactérie isolée en cas d'ECBU polymicrobien ou de recontrôler l'ECBU
  - ✓ de traiter 48 heures avant et jusqu'à 24 heures après

Prévention

- Il n’est pas recommandé de faire un ECBU avant ablation d’une sonde de néphrostomie ou d’un matériel urétéral en l’absence de symptômes

- Il est recommandé
  - ✓ de laisser le matériel endo-urétéral le moins longtemps possible
  - ✓ de ne pas prolonger un traitement antibiotique

Diagnostic

- Il est recommandé de :
  - ✓ réaliser un ECBU devant une suspicion d'infection sur matériel endo-urétéral
  - ✓ ne pas utiliser la bandelette urinaire
  - ✓ ne pas tenir compte de la leucocyturie
  - ✓ ne pas envoyer les sondes au laboratoire
  - ✓ de privilégier les signes cliniques aux seuils de bactériurie pour la décision thérapeutique
- L'intérêt de la CRP et de la procalcitonine n'est pas démontré

Traitement

- Il est recommandé de changer **en urgence** le matériel en cas :
  - ✓ de sepsis (quick SOFA ≥ 2) ou de choc septique
    ET
  - ✓ d'une dilatation du haut appareil urinaire

- Il n'est pas recommandé de changer systématiquement un matériel endo-urétéral en cas d'infection

- Situations **non urgentes** pouvant conduire à un changement du matériel (délai optimal non défini)
  - ✓ apparition ou majoration d'une dilatation du haut appareil
  - ✓ non amélioration clinique après 72 heures d'antibiothérapie bien conduite,
  - ✓ rechute ou récidive de l'infection sur matériel

Traitement probabiliste

- Absence de facteurs de risque d'EBLSE: pipéracilline-tazobactam
- Présence de facteurs de risque d'EBLSE* :
  - ✓ Patient non grave : pipéracilline-tazobactam
  - ✓ Patient avec signes de gravité : carbapénème
- Si choc septique : amikacine en association
- Prise en compte des résultats d'un ECBU de moins de 3 mois, avec BLSE: choix de la bétalactamine selon antibiogramme, en l'absence de signes de gravité
- Il est recommandé de traiter 5 jours en cas d'évolution rapidement favorable et 10 jours dans les autres situations

* Cf diapositive suivante

Facteurs de risque d’infection à EBLSE

Il est recommandé de prendre en compte les facteurs de risque suivants :

- exposition à un antibiotique (amoxicilline-acide clavulanique, C2G, C3G, fluoroquinolones) dans les 3 mois précédents
- antécédent de colonisation ou d’infection à entérobactérie résistante aux C3G dans les 3 mois
- antécédent d’une autre infection liée aux soins
- voyage à l’étranger dans les 3 mois